

Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

Sintomas, Diagnóstico e Avaliação Clínica

Módulo de Especialização em Gastroenterologia — Apostila 3 (Páginas 41–60). Este material aborda os mecanismos fisiopatológicos do refluxo, a avaliação clínica estruturada, os fenótipos da DRGE, as manifestações extraesofágicas e os principais métodos diagnósticos disponíveis na prática clínica contemporânea.

PARTE 3

GASTROENTEROLOGIA

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA



GASTROHCOLPPAIRY

of lower esophageal Sphincter muscle aten-Serosa,
ne because, submucosa rimad, micotade andonoere, Ser
elocaglachle one ind/veecar ofie cftcuch.

Mecanismos Relacionados à Hérnia Hiatal

A hérnia hiatal representa uma das condições anatômicas com maior impacto sobre a dinâmica do refluxo gastroesofágico. Quando parte do estômago migra para o tórax através do hiato diafragmático, ocorre uma série de alterações mecânicas que favorecem e intensificam o refluxo patológico.

Redução da Pressão do EEI

A hérnia hiatal compromete a competência do esfíncter esofágico inferior (EEI), reduzindo sua pressão basal e tornando-o menos eficaz como barreira antirrefluxo. Isso facilita a abertura inadvertida do esfíncter mesmo fora dos episódios de deglutição.

Aumento dos Episódios de Refluxo

Com a barreira mecânica comprometida, o número de episódios de refluxo por dia aumenta significativamente, tanto em repouso quanto durante as refeições. Os relaxamentos transitórios do EEI tornam-se mais frequentes e prolongados.

Retenção Ácida no Saco Herniário

O conteúdo ácido retido no saco herniário funciona como um reservatório de ácido acima do diafragma, amplificando a exposição esofágica ao ácido e prolongando o tempo de contato da mucosa com o material refluxado.

📌 **Resultado clínico:** A combinação desses mecanismos leva a uma exposição esofágica ao ácido significativamente maior, aumentando o risco de esofagite erosiva, Esôfago de Barrett e outras complicações da DRGE crônica.

Início da Avaliação Clínica: Abordagem Estruturada

Pilares da Avaliação Inicial

A abordagem clínica da DRGE começa com uma anamnese detalhada e estruturada, capaz de orientar o raciocínio diagnóstico antes mesmo de qualquer exame complementar. Três pilares fundamentam essa etapa inicial:

- **Identificação dos sintomas:** quais sintomas estão presentes — típicos (pirose, regurgitação) ou atípicos (tosse, rouquidão)
- **Frequência e intensidade:** episódios diários, semanais; impacto sobre qualidade de vida e sono
- **Fatores desencadeantes:** relação com alimentos, posição, esforço físico, uso de medicamentos

Por que a Anamnese é Central?

Na DRGE, os sintomas têm alta sensibilidade diagnóstica quando típicos. Estudos demonstram que pirose e regurgitação, ocorrendo mais de duas vezes por semana, têm valor preditivo positivo superior a 70% para confirmar a doença.

A caracterização completa dos sintomas também permite:

- Identificar fenótipos clínicos distintos (erosiva vs. não erosiva)
- Reconhecer sinais de alarme precocemente
- Orientar a necessidade de exames adicionais
- Guiar a escolha da abordagem terapêutica inicial

A coleta sistemática dessas informações evita investigações desnecessárias e acelera o diagnóstico na maioria dos casos.

Sintomas Típicos da DRGE

Os sintomas típicos da DRGE são aqueles diretamente relacionados ao contato do conteúdo gástrico com a mucosa esofágica. Sua presença orienta fortemente o diagnóstico clínico e justifica o início do tratamento empírico na maioria dos casos.

Pirose (Azia)

Sensação de queimação retroesternal que se irradia do epigástrio em direção à garganta. É o sintoma cardinal da DRGE, ocorrendo tipicamente após as refeições, ao deitar-se ou ao dobrar o tronco. Pode ser intensa o suficiente para despertar o paciente do sono.

Regurgitação

Retorno passivo e sem esforço do conteúdo gástrico ou esofágico à boca ou faringe. Frequentemente de sabor ácido ou amargo. Difere do vômito por não envolver contração diafragmática ativa. Pode ocorrer de forma isolada ou associada à pirose.

Fatores que Agravam os Sintomas



Refeições Volumosas

Aumentam a pressão intragástrica e prolongam o tempo de esvaziamento gástrico, favorecendo o refluxo.



Gorduras e Chocolate

Reduzem a pressão do EEI e retardam o esvaziamento gástrico, intensificando e prolongando os episódios de refluxo.



Álcool

Relaxa o EEI diretamente e irrita a mucosa esofágica, potencializando o dano tecidual causado pelo ácido.



Alimentos Ácidos

Tomate, frutas cítricas e bebidas carbonatadas aumentam a acidez intragástrica e estimulam nociceptores esofágicos.

Características da Pirose: Além do Ácido

Embora a pirose seja classicamente associada ao refluxo ácido, sua fisiopatologia é consideravelmente mais complexa. A queimação retroesternal pode ter diferentes origens, o que tem implicações diretas para o diagnóstico e o tratamento. Compreender esses mecanismos é essencial para a abordagem de pacientes refratários aos inibidores de bomba de prótons (IBP).



Refluxo Ácido

Mecanismo mais comum. O ácido clorídrico ativa nociceptores TRPV1 na mucosa esofágica, gerando a sensação de queimação. pH esofágico inferior a 4 durante o episódio.



Refluxo Não Ácido

Conteúdo com pH entre 4 e 7. Mesmo sem acidez significativa, pode estimular quimiorreceptores e mecanorreceptores esofágicos, gerando sintomas idênticos ao refluxo ácido.



Refluxo Biliar

Os ácidos biliares têm ação detergente direta sobre a mucosa esofágica e são particularmente lesivos. Mais comum em pacientes gastrectomizados ou com dismotilidade duodenogástrica significativa.



Estímulo Mecânico

A distensão do esôfago por volume de líquido ou gás pode ativar mecanorreceptores gerando pirose mesmo sem conteúdo ácido. Relevante em pacientes com hipersensibilidade esofágica.

 **Ponto clínico fundamental:** Nem toda pirose é causada apenas por ácido. Pacientes que não respondem adequadamente a altas doses de IBP devem ser investigados para refluxo não ácido, hipersensibilidade esofágica ou outras causas de dor torácica funcional.

Refluxo Não Ácido: Quando o pH Normal Não Exclui a Doença



Uma das descobertas mais relevantes nas últimas décadas foi a compreensão de que sintomas típicos de DRGE podem ocorrer mesmo quando o pH esofágico permanece dentro da faixa normal (pH entre 4 e 7). Esse fenômeno, denominado **refluxo não ácido**, tem importantes implicações diagnósticas e terapêuticas.

Mecanismos Explicativos

- **Grande volume de refluxo:** mesmo sem acidez, um volume elevado de conteúdo gástrico pode distender o esôfago e ativar mecanorreceptores sensíveis ao estiramento, gerando sintomas
- **Maior alcance no esôfago:** o conteúdo refluxado pode atingir o esôfago proximal e a faringe, estimulando receptores em regiões com menor limiar de sensibilidade
- **Tempo prolongado de contato:** a exposição prolongada da mucosa ao conteúdo não ácido (incluindo pepsina inativada e ácidos biliares) pode causar dano tecidual cumulativo e sensibilização dos nociceptores

O diagnóstico do refluxo não ácido requer **impedanciopHmetria**, que detecta todos os episódios de refluxo independentemente do pH, correlacionando-os com os sintomas do paciente em tempo real.

Sintomas Associados

Manifestações Além dos Sintomas Clássicos

Além dos sintomas cardinais (pirose e regurgitação), a DRGE pode se manifestar por um conjunto de sintomas associados que, quando presentes, ampliam o espectro clínico da doença e podem dificultar o diagnóstico diferencial. Esses sintomas surgem como consequência da irritação esofágica, da dismotilidade associada ou de mecanismos reflexos vagais.

Arroto Frequente (Eructação)

A eructação excessiva pode ocorrer por dois mecanismos: como tentativa reflexa do organismo de aliviar a distensão gástrica, ou como comportamento supragástrico aprendido. Em pacientes com DRGE, a aerofagia frequentemente coexiste e piora os episódios de refluxo ao aumentar transitoriamente a pressão intragástrica.

Náuseas

Frequentemente subestimadas como sintoma de DRGE, as náuseas podem ocorrer isoladamente ou acompanhar a pirose. Resultam da estimulação de aferentes vagais durante os episódios de refluxo e são mais comuns em pacientes com gastroparesia associada ou com maior sensibilidade visceral.

Odinofagia (Dor ao Engolir)

A dor durante a deglutição pode indicar inflamação esofágica significativa com ulcerações ou erosões extensas. Quando presente, deve alertar o clínico para a possibilidade de esofagite erosiva grave, esofagite infecciosa (especialmente em imunossuprimidos) ou esofagite eosinofílica como diagnóstico diferencial.

Quando o Refluxo Se Manifesta Fora do Esôfago

As manifestações extraesofágicas da DRGE representam um grupo de sintomas e condições causados ou agravados pelo refluxo gastroesofágico, porém localizados além do esôfago. Sua presença frequentemente leva a diagnósticos errados e tratamentos inadequados, pois o paciente pode não apresentar pirose ou regurgitação como queixas principais.

Manifestações Laringofaríngeas

- **Rouquidão crônica:** irritação das cordas vocais pelo conteúdo ácido — frequentemente matinal
- **Laringite posterior:** inflamação da região posterior da laringe, com edema e eritema aritenóideo característico
- **Globus faríngeo:** sensação persistente de "bolo na garganta" sem disfagia real — muito associada ao refluxo laringofaríngeo
- **Pigarro e tosse seca:** reflexo vagal desencadeado pela irritação esofágica alta ou laringea direta

Manifestações Respiratórias

- **Tosse crônica:** uma das causas mais comuns de tosse persistente em não fumantes. Mecanismo reflexo vagal ou aspiração microgótica
- **Asma relacionada ao refluxo:** o ácido pode desencadear broncoespasmo via reflexo vagal esôfago-brônquico ou por microaspiração direta
- **Faringite recorrente:** inflamação faríngea de repetição sem agente infeccioso identificável

Manifestações Orais

- **Erosão dental:** descalcificação do esmalte pelo ácido regurgitado — face palatina dos dentes superiores
- **Halitose:** odor ácido ou fétido decorrente do conteúdo regurgitado

❏ **Atenção diagnóstica:** Pacientes com tosse crônica, asma de difícil controle ou rouquidão persistente devem ser investigados para DRGE, mesmo na ausência de pirose. As manifestações extraesofágicas frequentemente confundem o diagnóstico e atrasam o tratamento adequado.

Complicações Respiratórias

DRGE e o Sistema Respiratório: Uma Relação Bidirecional

A relação entre DRGE e doenças respiratórias é complexa e frequentemente bidirecional: o refluxo pode causar ou agravar doenças pulmonares, e certas condições respiratórias (como o uso de broncodilatadores) podem, por sua vez, piorar o refluxo. Compreender essa relação é fundamental para o manejo adequado de pacientes com comorbidades pulmonares.

1 Broncoespasmo Reflexo

O ácido em contato com receptores esofágicos ativa um reflexo vagal que provoca broncoconstrição mesmo sem aspiração direta do conteúdo ácido para as vias aéreas. Esse mecanismo explica por que alguns pacientes asmáticos melhoram significativamente com o tratamento da DRGE, mesmo sem histórico de pirose evidente.

2 Pneumonia Aspirativa

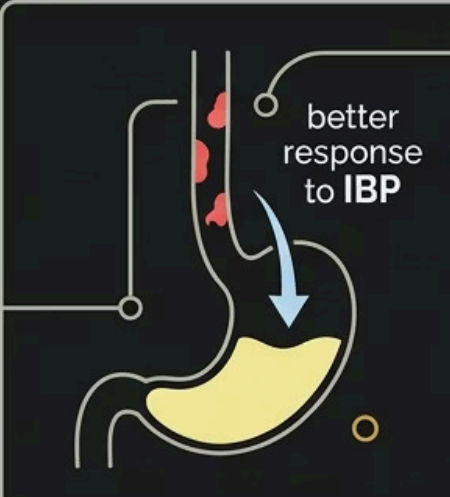
A microaspiração repetida de conteúdo gástrico para a árvore brônquica pode causar pneumonias recorrentes, especialmente no lobo inferior direito. É particularmente relevante em pacientes com dismotilidade esofágica, alterações neurológicas, intubação prolongada ou posicionamento supino prolongado.

3 Alterações Pulmonares Crônicas

A microaspiração crônica e subclínica pode contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de fibrose pulmonar idiopática, bronquiectasias e doença pulmonar obstrutiva crônica. Estudos recentes associam DRGE não tratada a pior prognóstico em pacientes com fibrose pulmonar idiopática.

Fenótipos da DRGE: Divisão Clínica Fundamental

O reconhecimento dos diferentes fenótipos da DRGE é essencial para a definição da conduta diagnóstica e terapêutica mais adequada. Cada fenótipo tem características clínicas, endoscópicas e prognósticas distintas, exigindo abordagens diferenciadas.



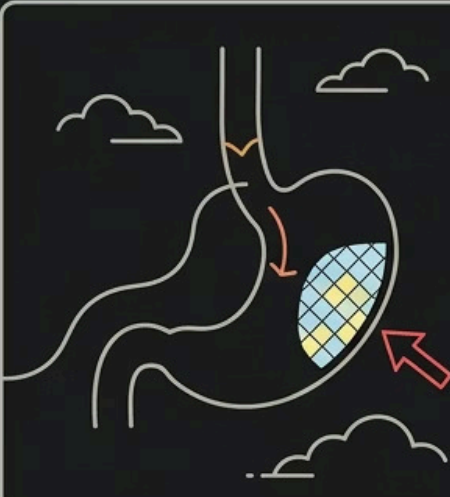
1) DRGE Erosiva

Sintomas presentes, endoscopia com erosões (Graus A-D de Los Angeles). Associada à hérnia hiatal. Resposta melhor aos IBP.



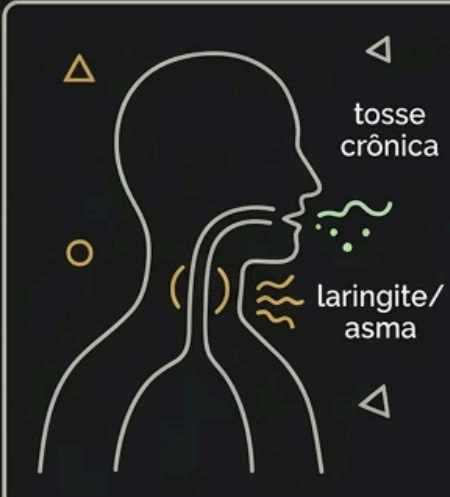
2) DRGE Não Erosiva

Forma mais comum (60-70%). Sintomas típicos. Endoscopia normal. Hipersensibilidade esofágica.



3) Esôfago de Barrett

Metaplasia intestinal da mucosa distal. Complicação crônica. Risco de adenocarcinoma. Necessita vigilância.



4) DRGE com Sintomas Específicos

Manifestações extraesofágicas dominantes (tosse crônica, laringite, asma). Sem necessariamente pirose típica.

A classificação em fenótipos guia decisões cruciais: pacientes com DRGE erosiva grave (grau C ou D) têm indicação de terapia de manutenção indefinida; pacientes com Esôfago de Barrett necessitam de vigilância endoscópica programada; e pacientes com DRGE não erosiva frequentemente se beneficiam de abordagem multimodal com manejo da hipersensibilidade visceral.

Avaliação Clínica e Teste Terapêutico com IBP

O Teste Terapêutico como Ferramenta Diagnóstica

Na prática clínica, o uso empírico de **inibidores de bomba de prótons (IBP)** em dose padrão por 4 a 8 semanas constitui um método diagnóstico válido e amplamente recomendado para pacientes com sintomas típicos de DRGE sem sinais de alarme. A lógica é simples: se os sintomas melhoram substancialmente com a supressão ácida, isso sugere fortemente que o ácido é o agente causal.

- Dose padrão: omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg ou equivalente, 30–60 min antes do café
- Duração mínima: 4 semanas para sintomas típicos; 8–12 semanas para manifestações extraesofágicas
- Resposta positiva: redução $\geq 50\%$ dos sintomas durante o tratamento
- Acurácia diagnóstica: sensibilidade ~71%, especificidade ~44% para DRGE típica

Quando o Teste Terapêutico é mais Útil?

O teste terapêutico com IBP tem maior utilidade clínica nas seguintes situações:

- **Sintomas típicos sem sinais de alarme** em pacientes jovens (abaixo de 45–50 anos)
- **Avaliação inicial** antes de solicitar exames invasivos
- **Sintomas extraesofágicos** com suspeita de relação com DRGE (tosse, laringite)
- **Contexto de atenção primária** onde exames complementares têm acesso limitado

Limitações

- Não exclui lesões orgânicas (câncer, Barrett) — não substitui endoscopia quando indicada
- Efeito placebo pode causar falso positivo
- Baixa especificidade: outras condições (dispepsia funcional) também respondem a IBP

Por que o Diagnóstico Clínico da DRGE Nem Sempre é Simples?

Apesar de a DRGE ser uma das condições gastroenterológicas mais prevalentes, seu diagnóstico clínico enfrenta desafios importantes que podem levar a erros — tanto de subdiagnóstico quanto de sobrediagnóstico. Compreender essas limitações é fundamental para uma prática clínica mais precisa e segura.

1

Sintomas Inespecíficos

Pirose e regurgitação, embora sugestivos, ocorrem em diversas condições. Dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, gastroparesia, acalasia e até doenças cardíacas podem mimetizar a DRGE com alta fidelidade clínica, tornando a anamnese isolada insuficiente para o diagnóstico definitivo.

2

Sobreposição com Outras Doenças

A DRGE frequentemente coexiste com outras condições funcionais (como dispepsia funcional em até 30–40% dos casos), tornando impossível atribuir os sintomas exclusivamente ao refluxo. Essa sobreposição complica tanto o diagnóstico quanto a avaliação da resposta ao tratamento.

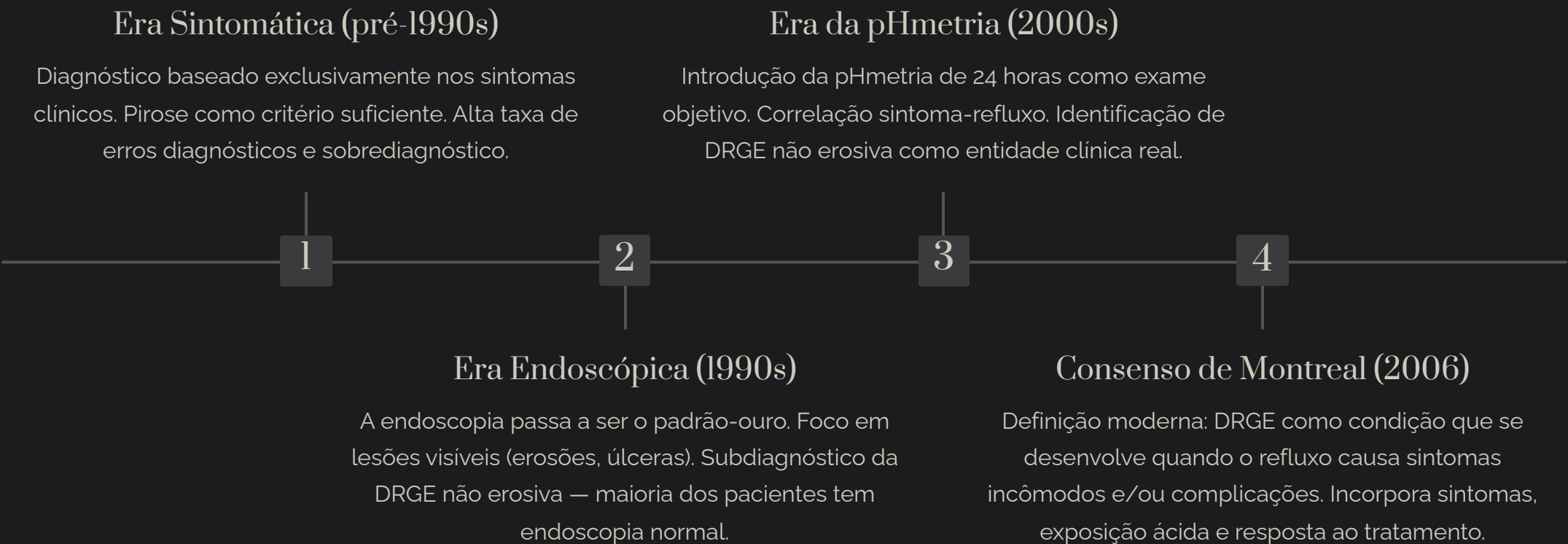
3

Percepção Individual Variável

A percepção dos sintomas varia enormemente entre indivíduos. Pacientes diabéticos, idosos e portadores de neuropatias autonômicas podem ter refluxo significativo com pouca ou nenhuma sintomatologia (DRGE "silenciosa"), enquanto pacientes com hipersensibilidade visceral relatam sintomas intensos com refluxo mínimo.

Evolução dos Critérios Diagnósticos da DRGE

O diagnóstico da DRGE passou por transformações conceituais importantes ao longo das últimas décadas, culminando na definição do **Consenso de Montreal (2006)**, que estabeleceu a base conceitual utilizada até hoje. Essa evolução reflete o amadurecimento científico no entendimento da doença.



Hoje, o diagnóstico integra três domínios complementares: **sintomas** (qualidade, frequência, impacto), **exposição ácida objetiva** (pHmetria ou impedanciopHmetria) e **resposta ao tratamento** (teste terapêutico com IBP). Essa abordagem tripartite reduz erros e individualiza a conduta.

Fenótipo Mais Prevalente

DRGE Não Erosiva: A Forma mais Comum da Doença

Definição e Prevalência

A DRGE não erosiva (DRGE-NE) é definida pela presença de sintomas típicos de refluxo com **endoscopia digestiva alta normal** — sem erosões, úlceras ou sinais de metaplasia. Representa **60 a 70% de todos os casos de DRGE**, sendo, portanto, a forma mais prevalente na prática clínica.

Sua alta prevalência contrasta com o histórico de subvalorização: durante anos, a endoscopia normal era interpretada como ausência de doença, levando ao subdiagnóstico sistemático dessa condição.

Mecanismos Envolvidos

- **Hipersensibilidade esofágica:** limiar reduzido de percepção de estímulos fisiológicos — pacientes sintomáticos com exposição ácida normal ou mínima
- **Exposição ácida aumentada com mucosa preservada:** dano funcional sem lesão macroscópica detectável à endoscopia convencional
- **Refluxo não ácido dominante:** sintomas mediados por volume ou bile, sem acidificação esofágica significativa

Associação com Distúrbios Funcionais

A DRGE-NE tem forte sobreposição com distúrbios funcionais do esôfago (pirose funcional, hipersensibilidade esofágica ao refluxo) definidos pelos Critérios de Roma IV. Essa sobreposição é clinicamente relevante porque determina diferença na resposta ao tratamento: pacientes com DRGE-NE verdadeira respondem bem aos IBP, enquanto aqueles com distúrbios funcionais têm resposta parcial ou nula.

Diagnóstico Diferencial

Não Confundir: Diagnóstico Diferencial da DRGE

O diagnóstico diferencial da DRGE é amplo e inclui condições com apresentação clínica semelhante. O erro diagnóstico pode ter consequências graves — tanto pelo tratamento inadequado quanto pelo atraso no diagnóstico de doenças potencialmente mais sérias. As três principais condições a considerar são:

Dispepsia Funcional

Síndrome caracterizada por desconforto ou dor epigástrica, plenitude pós-prandial e saciedade precoce, sem causa orgânica identificável. Sobreposição com DRGE em até 40% dos casos. A pHmetria normal e a ausência de correlação sintoma-refluxo ajudam a distinguir. Muitos pacientes com "DRGE refratária" têm, na verdade, dispepsia funcional sobreposta.

Esofagite Eosinofílica (EoE)

Doença inflamatória mediada por eosinófilos, com apresentação que pode mimetizar DRGE completamente. Mais prevalente em adultos jovens, atópicos. O diagnóstico requer biópsia esofágica com ≥ 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Não responde a IBP (ou responde parcialmente). Tratamento com corticoides tópicos, dieta de eliminação ou dupilumabe.

Doenças Cardíacas (Dor Torácica)

Dor torácica de origem cardíaca (angina, síndrome coronariana aguda) pode ser clinicamente indistinguível da pirose. A regra fundamental: sempre excluir causa cardíaca antes de atribuir dor torácica à DRGE, especialmente em pacientes com fatores de risco cardiovascular, dor aos esforços ou irradiação para membros superiores.

Condições Clínicas com Alta Associação à DRGE

Diversas condições sistêmicas e fisiológicas aumentam significativamente o risco e a gravidade da DRGE. O reconhecimento dessas associações permite uma abordagem preventiva e terapêutica mais eficaz, antecipando complicações em populações de risco.

→ Gravidez

Prevalência de DRGE durante a gestação pode atingir **40 a 85%** das gestantes — a mais alta de qualquer condição associada. Os mecanismos incluem o aumento da progesterona (que relaxa o EEI), o deslocamento cranial do estômago pelo útero gravídico e o aumento da pressão intra-abdominal. Os sintomas tipicamente pioram no terceiro trimestre e regredem após o parto. O tratamento é primariamente não farmacológico; antiácidos e alginatos são seguros; IBP devem ser reservados para casos refratários.

→ Síndrome de Zollinger-Ellison (SZE)

Tumor neuroendócrino produtor de gastrina (gastrinoma) que causa hipersecreção ácida maciça. A DRGE nesse contexto é grave, refratária e frequentemente associada a esofagite erosiva extensa e úlceras pépticas múltiplas. O diagnóstico é confirmado por dosagem de gastrina sérica em jejum e teste de secretina. Tratamento com altas doses de IBP e ressecção cirúrgica do tumor.

→ Esclerodermia (Esclerose Sistêmica)

A esclerodermia é a condição sistêmica com maior comprometimento esofágico — até **90% dos pacientes** têm algum grau de disfunção. A fibrose do músculo liso esofágico leva à hipomotilidade grave e à incompetência do EEI, resultando em DRGE severa com alto risco de esofagite erosiva, Esôfago de Barrett e adenocarcinoma. Requer manejo intensivo e vigilância endoscópica regular.

→ Pós-Cirurgias Esofágicas e Gástricas

Gastrectomia (especialmente a vertical sleeve), fundoplicatura com falha técnica, esofagectomia e cirurgias bariátricas podem alterar radicalmente a fisiologia antirrefluxo. O refluxo pós-cirúrgico frequentemente envolve conteúdo biliar e tem padrão distinto, sendo mais difícil de tratar com IBP convencionais.

Métodos Diagnósticos

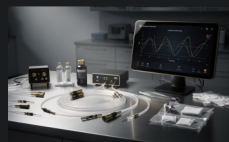
Arsenal Diagnóstico da DRGE: Exames Complementares

A escolha do método diagnóstico deve ser guiada pela hipótese clínica, pelo fenótipo suspeito e pelo objetivo específico da investigação — identificar refluxo, avaliar lesões ou estudar função esofágica. Cada exame tem indicações, vantagens e limitações bem definidas.



pHmetria de 24h

Padrão-ouro para documentar exposição ácida esofágica. Mede o pH no esôfago distal continuamente durante 24 horas. Fornece o índice DeMeester e o percentual de tempo com pH abaixo de 4. Ideal para confirmar DRGE antes de cirurgia antirrefluxo e em pacientes com sintomas atípicos ou refratários a IBP.



Impedanciometria

Combina a detecção de todos os episódios de refluxo (ácido e não ácido) com a correlação sintomática em tempo real. É o exame mais completo para investigação de DRGE, especialmente em pacientes em uso de IBP (on-therapy), com suspeita de refluxo não ácido ou com sintomas atípicos sem confirmação prévia da doença.



Endoscopia Digestiva Alta (EDA)

Principal exame para avaliar lesões da mucosa esofágica — erosões, úlceras, metaplasia de Barrett, estenoses. Permite biópsia para diagnóstico histológico. Indicada em presença de sinais de alarme, sintomas persistentes após 4–8 semanas de IBP, vigilância do Esôfago de Barrett e investigação de complicações da DRGE.



Manometria Esofágica

Avalia a função motora do esôfago: pressão e relaxamento do EEI, peristalse esofágica e função do esfíncter esofágico superior. Essencial antes da cirurgia antirrefluxo para excluir acalasia e identificar dismotilidade esofágica grave que contraindique funduplicatura. Não diagnostica refluxo diretamente.

Endoscopia Digestiva Alta: Indicações e Sinais de Alarme

Indicações da EDA na DRGE

A EDA não é necessária para o diagnóstico inicial de DRGE em pacientes jovens com sintomas típicos e sem sinais de alarme. No entanto, torna-se mandatória nas seguintes situações:

- Presença de qualquer sinal de alarme (ver ao lado)
- Sintomas persistentes após 4–8 semanas de IBP em dose adequada
- Idade acima de 45–50 anos com sintomas novos ou em piora
- Necessidade de confirmar diagnóstico antes de cirurgia antirrefluxo
- Vigilância do Esôfago de Barrett (intervalo conforme grau de displasia)
- Investigação de odinofagia ou disfagia progressiva
- Suspeita de esofagite eosinofílica (para biópsia)

⚠ Sinais de Alarme — Investigação Imediata

A presença de qualquer um dos sinais abaixo exige endoscopia imediata, independentemente da idade ou duração dos sintomas, pois podem indicar neoplasia ou complicação grave:

- **Disfagia progressiva:** dificuldade para engolir com piora gradual — suspeita de estenose, carcinoma ou acalasia
- **Perda de peso involuntária:** emagrecimento não intencional maior que 5–10% do peso corporal
- **Anemia ferropriva:** especialmente em homens e mulheres na pós-menopausa — pode indicar sangramento oculto
- **Sangramento digestivo:** hematêmese, melena ou sangue oculto nas fezes
- **Vômitos recorrentes e incoercíveis**
- **Massa abdominal palpável** ou linfonodomegalia
- **História familiar** de câncer esofágico ou gástrico

Classificação de Los Angeles e Savary-Miller

A padronização da descrição endoscópica das lesões esofágicas por refluxo é fundamental para a comunicação entre especialistas, a definição da conduta terapêutica e o acompanhamento evolutivo. Dois sistemas de classificação são os mais utilizados internacionalmente.

Classificação de Los Angeles

Sistema mais amplamente utilizado na atualidade. Classifica a esofagite erosiva com base na extensão das erosões mucosas, definidas como defeitos superficiais com bordas bem delimitadas:

- **Grau A:** uma ou mais erosões menores que 5 mm, não contínuas entre as cúspides das pregas mucosas. Esofagite *leve*
- **Grau B:** uma ou mais erosões maiores que 5 mm, não contínuas entre as cúspides. Esofagite *moderada*
- **Grau C:** erosões contínuas entre as cúspides de duas ou mais pregas mucosas, mas envolvendo menos que 75% da circunferência. Esofagite *extensa*
- **Grau D:** erosões envolvendo 75% ou mais da circunferência esofágica. Esofagite *grave* — alto risco de complicações

Classificação de Savary-Miller

Sistema mais antigo, ainda utilizado em alguns serviços. Inclui estágios que vão além das erosões, abrangendo complicações:

- **Grau I:** eritema ou erosão linear isolada — esofagite mínima
- **Grau II:** erosões múltiplas, não circulares — esofagite moderada
- **Grau III:** erosões circulares confluentes — esofagite grave
- **Grau IV:** complicações crônicas — úlcera, estenose péptica, Esôfago de Barrett
- **Grau V:** Esôfago de Barrett (adicionado posteriormente à classificação original)

Comparação Prática

A classificação de Los Angeles é preferida por sua **maior reprodutibilidade interobservador** e por focar exclusivamente nas lesões agudas. A Savary-Miller tem valor histórico e ainda é útil para registrar complicações como estenose e Barrett em serviços que a adotam tradicionalmente.

Pontos-Chave: DRGE — Avaliação Clínica e Diagnóstico

01

Hérnia Hiatal e Fisiopatologia

A hérnia hiatal compromete o EEI, aumenta os episódios de refluxo e retém ácido no saco herniário — amplificando a exposição esofágica. A pirose pode ter origem ácida, não ácida, biliar ou mecânica.

03

Fenótipos e Diagnóstico Diferencial

DRGE erosiva, não erosiva, Barrett e com sintomas específicos — cada fenótipo exige abordagem distinta. Excluir sempre: dispepsia funcional, esofagite eosinofílica e doenças cardíacas antes de confirmar DRGE.

02

Sintomas Típicos e Extraesofágicos

Pirose e regurgitação são os sintomas cardinais. Manifestações extraesofágicas (tosse crônica, laringite, asma, globus) frequentemente confundem o diagnóstico e exigem alto índice de suspeição clínica.

04

Métodos Diagnósticos e Sinais de Alarme

EDA para lesões; pHmetria/impedanciopHmetria para confirmar refluxo; manometria para função motora. Sinais de alarme (disfagia, emagrecimento, anemia, sangramento) exigem endoscopia imediata. A classificação de Los Angeles (graus A–D) padroniza a gravidade endoscópica.

📄 **Referências:** Consenso de Montreal (2006) • Diretrizes da ACG (American College of Gastroenterology) para DRGE • Critérios de Roma IV para distúrbios funcionais do esôfago • Diretrizes da Federação Brasileira de Gastroenterologia • Estudos clínicos em refluxo gastroesofágico e literatura médica especializada